

Conduites à tenir de Médecine Générale

Dr.KHERBA_N

Sommaire

ASLO ↗

Compléments alimentaires

Déclaration de la mort

Hypersialorrhée

Insomnie

Vitamine C

ASLO

● Demandez le dosage de ASLO devant:

Angines à répétition + Arthralgies et CRP/VS ↑

Néphropathie après une infection à strepto

■ AC Antistreptolysines O => attaque le strepto et les articulations

✓ Normal <200

■ Un taux significatif en Algérie >400

■ 2 prélèvements à 15j d'intervalle

■ Si Clinique (-) ou absence de critères de Jones => Pas de traitement

■ La signification de ↑ASLO => Infection à strepto récente cutanée, ORL..(3 derniers mois)

■ Une simple angine à strepto bien traité=> ↗
ASLO (réponse immunitaire physiologique)

■ Bilan: 

■ FNS

■ CRP/VS

■ Rénal

■ BU (Hématurie/Protéinurie) si (+)

■ Protéinurie des 24h + C3

à rechercher une Glomérulonéphrite post strepto surtout si hématurie après une infection à strepto

⊖ Si suspicion de RAA:

■ Rechercher: Souffle cardiaque, Arthralgies..

■ Rechercher les critères de Jones pour poser le diagnostic:

1 (2 majeurs ou 1 majeur et 2 mineurs)

2 Infection récente à streptocoque

3 ASLO ↗

+ Bilan: ⚪

■ FNS

■ CRP/VS

■ FR

→ Avis Cardio (Échocœur)

⊖ Si angines à répétition (au (-) 3/an pdt 3ans consécutifs ou 7/ans pdt 1an) → Avis ORL (Amygdaléctomie)

■ Rechercher une immunodépression: Bilan

■ FNS

■ Gly

■ Vit D

■ Sérologie

✓ Prophylaxie: si Angine à répétition et ASLO ↗
=> Amoxicilline 6j si allergie => Extencilline

Extencilline inj/21j 3inj puis refaire ASLO
en IM stricte dans une unité hospitalier
<30kg: 0.6M / >30kg: 1.2M

Ou Peni V 0.5 Mui/j per os 2/j

- Si allergie aux Pénicillines:
- Érythromycine 200mg/j 2/j

↗ASLO seul: est critère mineur même pas
majeur, en plus sans Clinique.. pourquoi on
cherche de traiter le patient

- Si RAA(+): 1inj/21j durée
- Sans cardite: 5ans ou jusqu'à 21ans
- Avec cardite sans séquelles: 10ans ou jusqu'à 25ans
- Avec cardite avec séquelles: au (-) 10ans ou jusqu'à 40ans

DIAGNOSTIC Les critères de JONES

les critères majeurs : ■ - Cardite (Myocardite, Péricardite, Endocardite ou Pancardite) ■ - Polyarthrite ■ - Chorée ■ - Erythème marginé ■ - Nodosités sous-cutanées de Meynet	les critères mineurs : ■ Fièvre, ■ arthralgie, ■ accélération de VS, hyperleucocytose à polynucléose, allongement de PR,
--	--

Infection streptococcique

- élévation du taux d'ASLO
- prélèvement de gorge positif

Le diagnostic de RAA repose sur :

- Deux critères majeurs **2M** + la preuve **1s** positif
- Ou un critère majeur + deux critères mineurs **1M+2m**+la preuve **1s**

Compléments alimentaires

- Mémoire → Juvamine mémoire/Gelphore
Mémoire et concentration/Memo Boost de
Phytolife/B9/Ginko biloba
- Oméga3 + Mg pour gérer le stress
- Arthrose, Arthrite, fatigue → Articure plus
1cp/j pdt 1mois à renouveler après 6mois, hors
les repas
- Déconseillé en cas de Dysthyroïdies
- Fatigue → Supradyn boost/Nutraxin/Sargenor
amp
- Polyvit: Alvityl cp
Sirop: Enf 1cac/j >6ans 2cac
- Solyn energy, energize gel 2/j (matin/soir)

■Appétit → Appetit

4/Digeval/Grossivit/Grossivit plus/Phyto
appetit/Appétit sirop/ Alvityl/Multi
vitamines/Nutraxin

■Enfant → Vitatine sp/Pediakid appetit
sp/Appetit kid/Grossivit plus bébé/Advitam
goutte/Solvityl

■Appetitina >6mois_5ans: 1cac 2/j
>5ans: 2cac 2/j

■Alvityl sirop 1cac 1/j

■Insomnie → Somnifères : Somnuit, Nuit d'or,
Mélatonine biomax, Magnol stress, Euphytose
nuit, Juvamine Mg

■Allaitement/Grossesse → Gynéform

■Allaitement → Lactomax
1cap/j/Stimulait/Theralact/Vitonic/Tisanes

■Phylait gel 1gel 3/j matin midi et soir

■Myralait cp 1cp 3/j

■SOPK → Myo inositol 1/j

■Sujets âgés → Alvityl cp/Okagé sac/Gelphore
amp/Biovit multivitamines

■Dyspepsie → Cibetaine/Effidigest/Ecitaine
amp

■Fortimel → Cancéreux

■Diabète → Gluco plus pour un meilleur
contrôle glycémique, il est utilisé même chez la
femme enciente au cours de diabète
gestationnel

■Troubles de digestion des viandes et des
protéines → les enzymes digestives bpn

■ Troubles de diarrhée et colopathie
fonctionnelle récurrent → Probiotiques instant

■ Troubles de libido chez les âgées qui ne
tolèrent pas la Viagra → Stimulum/Etumax gel

■ Enfants immunodéprimés → Manuka Solyne
Adulte → Défense solyne gel

■ Sportif → Energize 2gel matin/soir pdt 1sem,
puis 2gel matin pdt 3_4sem

Déclaration de la mort

- Signes (+):

- Refroidissement
- Déshydratation
- Lividité
- Rigidité
- Putréfaction

- Signes (-):

- Arrêt cardio respiratoire définitif
- Absence du pouls, TA nulle
- Absence des mouvements respiratoires
- Hypotonie généralisée (mâchoire tombe..)
- Mydriase latérale aréactive

- Types de mort:

- Naturel: Maladie dont l'évolution est fatale..
- Violent: accident, homicide, suicide
- Indéterminé (suspect): personne en bonne santé ou qui a une maladie mais non fatale,

absence d'explication..  Autopsie

 La déclaration: après 2h

Hypersialorrhée

- Soit par  des sécrétions salivaires ou un stase œsophagien
- Causes:
 - Trouble neurologique (maladie de Parkinson)
 - Prothèse mal adaptée
 - Tumeur œsophagienne
 - Carie dentaire
 - Infections
 - Stomatite
 - Diabète
- Explorations:

Chercher une parotidite, lithiase..

- CRP

- Échographie

- TDM

- ☒ Traitement étiologique

Insomnie

● Clinique :

Signes associés : Céphalées, fatigue, anxiété

Rechercher : habitudes toxiques, amaigrissement, hallucinations, stress, prise de café, thé..

■ Bilan : 

■ Gly à jeun

■ FNS

■ TSH

■ Vit D

✓ CAT :

■ Hygiène : pas de boissons excitants après 15h

■ Éviter les sucres et l'utilisation des écran la nuit (2h avant dormir)

Mais plutôt une tisane=> البابونج

☐ 1 Mg Solyne 1cp le soir

Ou Isomag sirop 1_2càs/j

☐ 2 Mélatonine gel 3mg 1gel/j le soir

Ou

Nuit d'or

Somnuit

Euphytose nuit

Juvamine mag

☐ → Avis psychiatre

Vitamine C

- 1mois_11ans: 100mg
- >12ans et adulte: 250mg

Ou

- 1mois_3ans: 100mg
- 4ans_11ans: 250mg
- >12ans et adulte: 500mg

- Sirop 250mg:
- <5ans: 1cac 1/j le matin
- >5ans: 1cac 2/j le matin et à midi

- Pas CI si grossesse ou allaitement

à ne pas dépasser 1g/j

- Nutripower=> femme enceinte/diabétique

